



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : زينب عبدالعزيز زيد منصور

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : شبرا الخيمة ثان العنوان : //

رقم البطاقة : 27810271401381 رقم التليفون : 01008277383 تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 27-10-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زينب عبدالعزيز منصور National ID: 27810271401381	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

زینب
عبدالعزیز زید متصور
١ ش البیومى -م العربیه
شبرا الخیمة ثانیه القلیوبیة

٢٧٨١٠٢٧١٤٠١٣٨١

KE3338197

٢٠٢٣/٠٩ ٢٧٨١٠٢٧١٤٠١٣٨١
حاصلة على دبلوم معهد فنى تجارى

انثى
مملوكة
متزوجة
عماد محمد محمد حسين عياد

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٩/٢٩

8-Patient ID
1-Name:

2-DOB

MDT Form

3-Referral number
Example

0250141
012121

11/11/2024



4-Referral type

5-Referral

0121212121

6-Ref

REASON OF MDT

7-Referral date

8-Referral

9-Referral

Date of MDT

10-Referral

11-Referral

12-Referral

13-Referral

Clinical data

14-Referral

Breast Imaging

15-Referral	16-Referral	17-Referral	18-Referral	19-Referral	20-Referral
21-Referral	22-Referral	23-Referral	24-Referral	25-Referral	26-Referral
27-Referral	28-Referral	29-Referral	30-Referral	31-Referral	32-Referral
33-Referral	34-Referral	35-Referral	36-Referral	37-Referral	38-Referral
39-Referral	40-Referral	41-Referral	42-Referral	43-Referral	44-Referral
45-Referral	46-Referral	47-Referral	48-Referral	49-Referral	50-Referral

51-Referral

PATIENT HISTORY

52-Referral
53-Referral
54-Referral
55-Referral
56-Referral
57-Referral
58-Referral
59-Referral
60-Referral

MDT OUTCOME & PLAN

61-Referral
62-Referral
63-Referral
64-Referral
65-Referral
66-Referral
67-Referral
68-Referral
69-Referral
70-Referral

71-Referral

72-Referral

73-Referral

74-Referral

75-Referral

76-Referral

77-Referral

Patient Name : الأستاذة / رينيه - عبد العزيز زيد

Patient No. : 27810271401381

Pate No. : 4679/24

Sex : Female

Age : 46 Y

Referring Doc :

Request No. : 13000823

Request Date : 28/11/2024

Verification Date : 07/12/2024

Financial Category : نفقة الدولة - ارقام دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data :

Left breast cancer post NACT.

Material of the specimen :

Left wide local excision and axillary lymph node dissection specimens collected at 25/11/2024.

Gross Examination:

Left wide local excision specimen measured 12.5x7x1.5 cm , with covering skin ellipse measuring 12x3 cm.

Left axillary lymph node dissection specimen: An ill defined rubbery greyish white tumor bed site (wired). Size: 1.8x1.6x1 cm.

Distance from margins: 0.5 cm from deep margin, 1 cm from skin, 3 cm from medial margin, 4 cm from lateral margin, 2.5 cm from superior margin and 1.5 cm from inferior margin.

Right axillary lymph node dissection specimen: Fibrofatty tissue piece measured 5x4x1 cm containing 12 LNs up to 0.7x0.5 cm.

Frozen section:

Free margins

Microscopic examination:

- Total tumor regression in a previously diagnosed carcinoma.
- Lymph node involvement: Positive (5/12).
- Resection Margins: Free, resected margins.
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response.

Diagnosis:

Verified by :

Dinaa magdy

DCS

Printing Date : 11/12/2024 13:17:39

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed yous

شارقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (287) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 287 - Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / زينب عبد العزيز زيد

Patient No. : 2781027*401381

Pate No. : 4679/24

Sex : Female

Age : 46 Y

Referring Doc :

Request No. : 13000823

Request Date : 28/11/2024

Verification Date : 07/12/2024

Financial Category : نفقة الدولة - وزارة دار السلام

Department : Out Patient

Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Left breast cancer post NACT , wide local excision and axillary lymph node dissection specimens :

Total tumor regression in a previously diagnosed invasive carcinoma.

Free resected margins.

Lymph nodes: Positive (5/12).

Pathologic partial response.

Stage : ypT0 , v5N2

ACB : 457 class III.

Dr. Sherif Abdelatt

Dr. Sherif Muhammed

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 11/12/2024 : 17:39

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - عصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: zainb abdelaziz zaïd

Date: 21/1/2024

CT chest, abdomen & pelvis with oral and IV contrast

I- CT chest

- Known patient of breast cancer
- Left upper outer quadrant multicentric malignant looking breast lesions the largest is about 27x18mm associated with diffuse skin thickening
- Left axillary pathological LNs detected at level I&II, the largest is measuring 12X11mm
- Right axillary LNs likely non specific for US correlation.
- Left lower lobe basal posterior subpleural ground glass veiling likely post inflammatory sequel.
- Right middle lobe para cardiac nodule with ground glass veiling likely inflammatory for follow up .
- No evidence of pulmonary nodules or masses.
- No evidence of sizable hilar or mediastinal lymphadenopathy.
- Patent trachea and both bronchi
- No pleural effusion.
- Normal cardiac size & configuration.

II- CT abdomen & pelvis

- Liver shows normal size, with homogenous CT attenuation. No focal lesion or calcification in the hepatic parenchyma. The porta hepatis is normal. No IHBR or CBD dilatation.
- Gall bladder shows no hyperdense stones .
- Pancreas appears normal in size and architecture. Pancreatic duct is not dilated.
- Spleen is normal in size and architecture. No focal lesion.
- Both kidneys reveal normal in size, shape, position and attenuation. No mass lesion, bilateral tiny stones are noted. No signs of obstructive uropathy are detected.
- Both adrenals are visualized normally.

Age / Gender 44 Years - Female
Registered Date 2023-11-26 08:27 ص
Reporting Date 2023-12-04 10:53 ص

Visit No. 0-2236
Patient Name زينب عبد العزيز زيد منصور

PATHOLOGY REPORT

Specimen : Tru- cut biopsy from:
1: Left axillary L.N.
2: Left breast UOQ at 2 o'clock mass.

Gross :

I: Multiple greyish yellowish tissue cores measured collectively 1x1cm, Submitted in (1).
III: Three greyish yellowish tissue cores each measured 1.3cm long; submitted in (2).

Diagnosis :

Microscopic & Diagnosis:

1: Left axillary lymph node, tru cut biopsy:
Mestastatic deposits in nodal tissue.
2: Left breast UOQ mass, tru cut biopsy;
Invasive duct carcinoma , grade2.

Immunohistochemical Interpretation:

- ER: Strong nuclear positivity of 70% of neoplastic cells (Allred score 8/8).
- PR: Strong nuclear positivity of 50 % of neoplastic cells (Allred score 7/8).
- Her2neu: strong membranous positivity in > 10% of neoplastic cells (3+).
- Ki-67: Strong nuclear positivity of 50% of neoplastic cells.

esraa essam

Signature

Prof. Dr. Sarah Adel.
2/12/2023



Patient Name: Zainab Abdel Aziz Zaid Mansour	Date : 13/10/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 1175/2024	Pat. ID: 65101

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

Heterogenous dense fibro glandular density (ACR C)

Left UOQ architectural distortion with micro calcific foci with skin dimpling.

Complementary ultrasound :

Stationary course of Left UOQ parenchyma distortion roughly measuring about 25x15mm.

No right cystic or solid mass lesions.

Normal right skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.

Left axilla two pathological LNs with effaced hilum one of them showing irregular outline measuring about 5x5mm.

Nonspecific right axillary LN.

Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

Left UOQ pathologically proven carcinoma showing no radiological response with ipsilateral pathological axillary LNs (BIRADS 6).

Signature Dr. Wafaa Ali

13/10/2024 3:10 PM

Ain Shams University Hospitals
Radiology department



مستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة النووية

Patient Name	زينب عبدالعزيز زيد منصور	PID	1021012329 3070	D/T	29-12-2023
--------------	--------------------------	-----	--------------------	-----	------------

Tc^{99m} MDP whole body bone scan

History:

44-year-old male patient, known case of unresected left breast cancer, no treatment has been received till now.

Technique:

Whole body anterior and posterior blood-pool and delayed 3 hours scans were taken after IV injection of 20 mCi of Tc^{99m} MDP.

Findings:

a) Bone lesions:

- Homogenous tracer distribution through the surveyed skeleton
- There are no osseous lesions suspicious for metastatic disease.
- Degenerative changes of the sternum, both shoulders and knees joints with warm tracer uptake

b) Other findings:

- Soft tissue contours are unremarkable.
- Both kidneys are visualized.

Impression:

The surveyed skeleton is free from metastatic osseous deposits.

Hayam Gamal, MSc

Dr. Basant Raief, MD

Email: feedbackradiology@gmail.com

رئيس شارع - شمس عين جامعة مستشفيات
القاهرة العباسية



Age / Gender: 44 Years - Female
Registered Date: 2023-11-26 08:27 ص
Reporting Date: 2023-12-04 10:53 ص

Visit No: 0-2236
Patient Name: زينب عبد العزيز زيد منصور

PATHOLOGY REPORT

Specimen : Tru- cut biopsy from:
1: Left axillary L.N.
2: Left breast UOQ at 2 o'clock mass.

Gross :

I: Multiple greyish yellowish tissue cores measured collectively 1x1cm, Submitted in (1).
III: Three greyish yellowish tissue cores each measured 1.3cm long; submitted in (2).

Diagnosis :

Microscopic & Diagnosis:

1: Left axillary lymph node, tru cut biopsy:
Metastatic deposits in nodal tissue.
2: Left breast UOQ mass, tru cut biopsy;
Invasive duct carcinoma , grade2.

Immunohistochemical interpretation:

- ER: Strong nuclear positivity of 70% of neoplastic cells (Allred score 8/8).
- PR: Strong nuclear positivity of 50 % of neoplastic cells (Allred score 7/8).
- Her2neu: strong membranous positivity in > 10% of neoplastic cells (3+).
- Ki-67: Strong nuclear positivity of 50% of neoplastic cells.

esraa essam

Signature

Prof. Dr. Sarah Adel.
2/12/2023



Patient Name	زينب، عبدالعزيز زيد منصور	PID	1021012329 3070	D/T	21-11-2023
--------------	---------------------------	-----	--------------------	-----	------------

SONOMAMMOGRAPHY OF BOTH BREASTS

Procedure: Digital mammography and real time ultrasonography of both breasts were performed.

Findings:

- Both breasts display normal skin thickness with normal appearance of the nipples and sub-areolar regions.
- Normal appearance of the subcutaneous fat on both sides.
- The breast p^hyma shows scattered fibro-glandular densities (ACR breast density 2)

Left Breast: An irregular slightly hyper dense lesion seen at the UOQ showing multiple foci of micro-calcifications with related skin dimpling with another similar lesion at the axilla showing microcalcifications. Complementary US an irregular hypoechoic lesion, measuring 2.8x2.2x3.2 cm is seen in the upper outer quadrant of the left breast at 1 O'clock position, almost 3 cm from the nipple showing speculated outlines.

- Another slightly irregular 1.5x1 cm lesion is seen at the left axillary tail likely representing similar suspicious lesion/pathological lymph nodes.

Axilla: Multiple pathologically looking left axillary lymph nodes are seen, showing rounded contour with attenuated hilum & increased cortical thickness.

- Right retro-areolar small hypoechoic lesion measuring 1.4x0.5 cm likely representing fibroadenoma.

- No suspicious solid or cystic masses or abnormal calcifications were detected in the right breast.

- No suspicious right axillary lymph nodes.

Impression:

MULTIFOCAL LEFT BREAST UOQ SOFT TISSUE LESIONS (TWO IN NUMBER),
LIKELY OF A MALIGNANT NATURE, WITH ASSOCIATED SUSPICIOUS LEFT
SIDED AXILLARY ADENOPHTHY. (BIRAD 5)
RIGHT RETRO-AREOLAR BENIGN LOOKING LESION LIKELY FIBROADNOMA.

MUHAMMAD G.ABDELATTY, MSC

- The IVC, aorta and portal vein are within normal position and caliber. No evidence of retroperitoneal lymphadenopathy or ascites.
- Urinary bladder reveals normal lumen and walls. No vesical calculi, wall thickening or mass lesion.

III Examined skeleton

Visualized osseous structures shows no worrisome lytic bony lesion. Tiny sclerotic lesion at D7 likely bone island

No vertebral collapse or extra osseous soft tissue.

Conclusion :

Left breast multi-centric malignant looking lesions with ipsilateral metastatic axillary lymphadenopathy

No definite pulmonary, hepatic or osseous metastases

Tiny sclerotic lesion at D7 likely bone island

Bilateral renal tiny stones

Much Obligated

Dr. Nermeen Ramadan, MD.

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

زوينب
عبد العزيز زيد منصور
١ ش البيومي دم الحرية
شبرا الخيمة ثان - القليوبية

٢٧٨١٠٢٧١٤٠١٣٨١

KE3338197

DMS
تة كيس

~~٢٧٨١٠٢٧١٤٠١٣٨١~~

وصيتا

٢٠٢٣/٠٩ ٢٧٨١٠٢٧١٤٠١٣٨١
حاصلة على دبلوم معهد فنى تجارى

البنى
مسلمة
متزوجة
عماد محمد محمد هاشم عبيد

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٩/٢٩

١١